

A eficácia da teleterapia síncrona em comparação com a terapia presencial: uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados

Tao Lin¹, Timothy G. Heckman² e Timothy Anderson¹¹ Departamento de Psicologia, Universidade de Ohio² Faculdade de Saúde Pública, Universidade da Geórgia

Apesar do uso crescente da teleterapia, ainda não está claro se os resultados dos clientes diferem entre ambientes remotos e presenciais e, se diferem, quais fatores podem contribuir para essas diferenças. O presente estudo sintetizou os resultados da comparação entre teleterapia e terapia presencial usando uma abordagem meta-analítica. Todos os RCTs conhecidos que comparam a teleterapia (terapia por telefone e videoconferência) com a terapia presencial foram identificados por meio de pesquisa em bancos de dados bibliográficos (*PsycINFO*, Medline e Cochrane), pesquisas manuais de meta-análises publicadas anteriormente e contato com especialistas. Identificamos 1.393 estudos na pesquisa inicial, dos quais 20 satisfizeram os critérios de inclusão do estudo. Não foi encontrada diferença significativa entre a teleterapia e a terapia presencial nos resultados do tratamento após o tratamento ($g = -0,043$) ou acompanhamento ($g = -0,045$) ou nas taxas de desistência ($RR = 1,006$). Os terapeutas em formação tiveram taxas de desistência de clientes maiores na teleterapia do que os terapeutas licenciados. A terapia por videoconferência apresentou maior risco de desistência dos clientes do que a terapia por telefone. Os resultados dentro do grupo mostraram que a teleterapia produziu uma redução significativa dos sintomas após o tratamento ($g = 1,026$) e no acompanhamento ($g = 1,021$). Esses resultados fornecem suporte empírico para a prática da teleterapia e mostram que os resultados dos clientes na teleterapia não diferem dos resultados dos tratamentos presenciais.

Declaração de importância para a saúde pública

A teleterapia produz resultados comparáveis aos da terapia presencial. Os terapeutas em formação correm um risco maior de perda de clientes na teleterapia do que os terapeutas licenciados.

Palavras-chave: teleterapia, meta-análise, terapia presencial, desistência, telepsicologia

Materiais complementares: <https://doi.org/10.1037/cps0000056.suppl>

A teleterapia é definida como a administração de psicoterapia utilizando tecnologias remotas (Telepsychology Task Force, 2013). A teleterapia pode ser administrada de forma assíncrona e síncrona. A teleterapia assíncrona, como a terapia computadorizada e a terapia administrada pela Internet, envolve o acesso dos clientes a materiais de intervenção com vários níveis de apoio clínico (Woot-ton, 2016). A interação cliente-terapeuta na teleterapia assíncrona não é conduzida em tempo real (Varker et al., 2019). Em contrapartida, a teleterapia síncrona é semelhante à terapia tradicional presencial no que diz respeito à intensidade do tratamento (Varker et al., 2019), na qual clientes e terapeutas interagem em tempo real sem estarem no mesmo local.

mesma sala. A teleterapia síncrona mais comum inclui videoconferência e terapia por telefone (Sammons et al., 2020).

Muitas pessoas relatam barreiras ao acesso a tratamentos psicológicos, tais como limitações de tempo, preocupações relacionadas com os custos, inconvenientes de transporte e estigma percebido (Marques et al., 2010; Mohr et al., 2006). A teleterapia pode contornar essas barreiras e permitir que as pessoas recebam terapia independentemente da sua localização geográfica (Brenes et al., 2011; Kafali et al., 2014). Além de sua conveniência e acessibilidade, a teleterapia é potencialmente vantajosa para pacientes com transtornos que os impedem de comparecer a tratamentos presenciais, como ansiedade social e transtornos de pânico (Chiauzzi et al., 2020).

Nas últimas décadas, tem-se observado um aumento nas pesquisas e na prática da teleterapia (Brenes et al., 2011; Glueckauf et al., 2018; Pierce et al., 2019; Varker et al., 2019). Uma pesquisa nacional nos Estados Unidos sobre a prática da teleterapia entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016 descobriu que 43% dos terapeutas administravam pelo menos “algumas horas” de terapia remota por semana (Glueckauf et al., 2018). No início de 2020, em grande parte devido à pandemia da COVID-19, a teleterapia passou rapidamente de um tratamento complementar para uma prática padrão (Markowitz et al., 2021; Pierce et al., 2021; Sammons et al., 2020). A proporção de serviços clínicos administrados remotamente aumentou para 85,53% em 2020 e provavelmente

Este artigo foi publicado online pela primeira vez em 30 de dezembro de 2021. Tao Lin <https://orcid.org/0000-0002-8883-870X> Timothy Anderson <https://orcid.org/0000-0001-7224-2728>

A pesquisa relatada nesta publicação foi apoiada, em parte, pela Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas dos Institutos Nacionais de Saúde, Prêmio R21DA047893.

A correspondência relativa a este artigo deve ser endereçada a Timothy Anderson, Departamento de Psicologia, Universidade de Ohio, 22 Richland Avenue, Athens, OH 45701, Estados Unidos. E-mail: andersot@ohio.edu

permanecer muito alta após a pandemia (Pierce et al., 2021). A maior prática da teleterapia requer uma avaliação da eficácia e adequação da teleterapia em comparação com a terapia presencial e a identificação de fatores que facilitam ou dificultam sua eficácia.

A eficácia da teleterapia síncrona

Ensaio clínico anterior demonstraram a eficácia da teleterapia síncrona para uma variedade de transtornos de saúde mental, incluindo depressão (Egede et al., 2015), ansiedade (Stubblings et al., 2013), transtorno de estresse pós-traumático (TEPT; Acierno et al., 2016, 2017), transtorno do pânico (Bouchard et al., 2004) e transtorno alimentar (Mitchell et al., 2008). Várias revisões de tratamentos de teleterapia síncrona foram publicadas (Bee et al., 2008; Bolton & Dorstyn, 2015; Mohr et al., 2008; Osenbach et al., 2013; Varker et al., 2019; Wootton, 2016). Por exemplo, Mohr et al. (2008) sintetizaram 12 ensaios de terapia por telefone e encontraram efeitos significativos da terapia por telefone para a depressão. Osenbach et al. (2013) atualizaram as descobertas incluindo 14 estudos de videoconferência e terapia por telefone para depressão e encontraram resultados semelhantes. Em uma meta-análise de dezoito estudos sobre terapia cognitivo-comportamental (TCC) remota, a TCC remota resultou em melhorias significativas es para sintomas obsessivo-compulsivos (Wootton, 2016). Além disso, Hilty et al. (2013) revisaram a eficácia da telepsicologia e descobriram que a telepsicologia é eficaz para diagnóstico e avaliação em diferentes faixas etárias e grupos étnicos e em vários contextos.

Embora meta-análises anteriores sugiram que a teleterapia é eficaz, não está claro se ela é igualmente eficaz quanto a terapia presencial. No entanto, as metanálises anteriores incluíram estudos que compararam a tele-psicologia a vários tipos de grupos de controle, incluindo tratamento habitual (TAU), controles em lista de espera e terapia presencial usando o mesmo manual de tratamento ou um diferente (Mohr et al., 2008; Osenbach et al., 2013; Wootton, 2016). Por exemplo, na meta-análise de Wootton (2016), apenas quatro dos dezoito estudos incluídos compararam a terapia remota ao tratamento presencial. Até o momento, nenhuma meta-análise examinou se a teleterapia e a terapia presencial produzem resultados diferentes em comparações diretas, controlando outros fatores relevantes (ou seja, com amostras, clientes, terapeutas e manuais de tratamento semelhantes).

O grande número de estudos sobre teleterapia publicados desde a meta-análise mais recente, juntamente com a rápida adoção da teleterapia em resposta à COVID-19, justificam a realização de uma meta-análise atual (Pierce et al., 2021). Além disso, as meta-análises anteriores se concentraram principalmente em uma única categoria diagnóstica (Wootton, 2016) e em uma única ferramenta de telecomunicação (ou seja, apenas telefone; Mohr et al., 2008). Os potenciais moderadores da eficácia da teleterapia em comparação com a terapia presencial, tais como a categoria diagnóstica e o formato da teleterapia, continuaram por estudar (Chiauzzi et al., 2020). Ainda não foi determinado para quais pacientes com quais condições a teleterapia é mais eficaz — talvez até mais eficaz do que a terapia presencial. Por exemplo, Chiauzzi et al. (2020) sugeriram que a teleterapia pode ser preferível para clientes do sexo feminino devido à sua responsabilidade pelo cuidado familiar e. Além disso, clientes mais velhos podem enfrentar mais desafios ao tentar acessar e usar tecnologias e, portanto, podem preferir a terapia presencial.

Os terapeutas mais jovens relatam maiores preocupações na prestação de teleterapia e habilidades terapêuticas comuns mais fracas na teleterapia do que os mais velhos.

terapeutas (Lin et al., 2021, no prelo). Esse padrão pode existir porque os terapeutas mais velhos têm experiência clínica e competência suficientes para adaptar suas habilidades às tecnologias remotas. Além disso, a terapia por videoconferência pode ser preferível à terapia apenas por áudio, uma vez que pode fornecer pistas visuais e é mais semelhante à comunicação presencial. A duração do tratamento é outro fator potencial na determinação da adequação da teleterapia, pois pode ser mais desafiadora, exigindo mais tempo para que os terapeutas construam uma aliança com os pacientes na ausência de contato interpessoal e presença física. Assim, pode ser valioso examinar se esses fatores relacionados a pacientes, terapeutas e tratamentos podem moderar a eficácia da teleterapia.

O presente estudo (a) amplia a literatura e sintetiza as pesquisas sobre a eficácia da telepsicologia síncrona (terapia por telefone e videoconferência) em comparação com a terapia presencial após o tratamento e no acompanhamento, (b) identifica potenciais preditores da eficácia da telepsicologia síncrona em comparação com a terapia presencial e (c) examina as diferenças nas taxas de desistência da telepsicologia síncrona em comparação com a terapia presencial.

Método

Registro do protocolo e estratégia de pesquisa

Seguindo os Itens Preferenciais para Relatórios de Revisões Sistemáticas e Meta-Análises (PRISMA; Moher et al., 2009), esta meta-análise foi pré-registrada no PROSPERO (CRD42020183998) com os métodos relevantes de revisão especificados antecipadamente. Realizamos uma extensa pesquisa sistemática da literatura para identificar estudos publicados e não publicados de 1964 a maio de 2020 para inclusão na meta-análise. Primeiro, três bancos de dados bibliográficos (PsycINFO, Medline e Cochrane Library) foram pesquisados em 24/07/2021, com foco em títulos e resumos, combinando termos indicativos de teleterapia, terapia presencial e ensaios clínicos randomizados (RCTs): Pesquisado no PsycINFO e MEDLINE (todos os anos): (tele-phone ou phone ou audio ou tele* ou videoconferenc* ou video) E (psychotherapy ou counseling ou therapy) E (ensaio ou RCT ou randomizado) E (presencial OU cara a cara OU tradicional OU no local)

Pesquisa na Biblioteca Cochrane (todos os anos): (telefone ou áudio ou tele* ou videoconferência* ou vídeo):ti E (psicoterapia ou aconselhamento ou terapia):ab E ("presencial" OU face a face OU tradicional OU no local OU pessoalmente OU "em pessoa"):ab

Em segundo lugar, foi realizada uma pesquisa manual de artigos relevantes, revisando a literatura citada em meta-análises e revisões sistemáticas anteriores sobre teleterapia. Especialistas na área também foram contatados para obter informações sobre ensaios em andamento ou recentemente concluídos que atendessem aos critérios de inclusão da meta-análise (descritos abaixo). Além disso, foi realizada uma pesquisa de referência para identificar artigos que citam os artigos incluídos. Por fim, cruzamos os resultados da nossa pesquisa com meta-análises e revisões anteriores relacionadas à teleterapia.

Crerios de inclusão e exclusão

Cada estudo incluído satisfz os seguintes critérios de inclusão:

(a) o estudo era um ensaio clínico randomizado de terapia administrada por telefone ou videoconferência em comparação com terapia presencial

terapia, (b) a intervenção incluiu quatro ou mais sessões individuais de terapia, (c) a terapia foi ministrada por profissionais de saúde, tais como terapeutas licenciados, psicólogos, conselheiros, assistentes sociais, enfermeiros, psiquiatras e estudantes que estavam recebendo treinamento clínico, (d) o tratamento presencial e o tratamento por teleterapia seguiram o mesmo manual de tratamento, (e) o desenho do RCT incluía avaliações pré e pós-tratamento dos sintomas de saúde mental utilizando uma medida validada, (f) os pacientes eram adultos (maiores de 18 anos) com sintomas de saúde mental indicados por medidas de sintomas ou diagnósticos clínicos, e (g) havia 10 ou mais pacientes em cada condição de tratamento.

Os estudos foram excluídos se (a) incluísssem pacientes em ambientes hospitalares; (b) o tratamento fosse administrado por meio de uma linha direta telefônica, serviço de aconselhamento em crises ou outro serviço psicológico de curto prazo; (c) a intervenção psicológica fosse adjuvante a outro tratamento (por exemplo, fisioterapia, farmacoterapia); (d) o tratamento fosse terapia da fala, linguagem ou terapia ocupacional ou limitado ao apoio social; ou (e) o estudo fosse duplicado em um ou mais estudos incluídos. Como os pesquisadores às vezes publicam vários estudos com base nos mesmos dados, seguimos as recomendações de Wood (2008) para estratégias de detecção de estudos duplicados, a fim de evitar os problemas da multiplicidade. Se estudos duplicados fossem identificados, o estudo com os dados mais abrangentes era incluído e os outros eram excluídos.

Avaliação do risco de viés e extração de dados

O risco de viés de cada estudo foi avaliado utilizando a ferramenta de avaliação de risco de viés da Cochrane Library e o Cochrane Handbook (Higgins et al., 2020). As seguintes fontes de viés em cada estudo foram classificadas como risco alto, baixo ou incerto: geração de sequências (se o estudo utilizou métodos adequados para gerar grupos comparáveis); dados incompletos de resultados (a completude dos dados de resultados para cada resultado principal); relato seletivo de resultados (a possibilidade de relato seletivo de resultados); diferença na linha de base (se existiam diferenças na linha de base entre as condições de tratamento); adesão ao tratamento (se a adesão dos pacientes ao tratamento foi aceitável); viés de atrito (se a taxa de atrito em cada condição de tratamento é aceitável); viés de intenção de tratar (se todos os pacientes e es foram incluídos na análise, independentemente do número de pesquisas de acompanhamento que completaram); e pré-registrado (se o estudo e e foi pré-registrado).

As características e os dados de cada estudo foram extraídos utilizando um livro de códigos pré-desenvolvido (ver [materiais complementares online](#)). As seguintes informações foram extraídas de cada estudo: descrição do artigo (tipo de estudo; ano de publicação; títulos; autores; país), descrição do tratamento (formato: videoconferência, telefone; duração da sessão; modalidade; características do provedor; ambiente), características do paciente (idade; sexo; diagnósticos; etnia; região: urbana ou rural), resultados primários, resultados secundários e taxas de desistência. As médias e os desvios padrão das avaliações pré-tratamento, pós-tratamento e de acompanhamento das principais variáveis de resultado foram extraídos para calcular os tamanhos dos efeitos. Se esses dados não fossem relatados, outros dados relevantes eram usados (por exemplo, tamanhos dos efeitos da mudança e intervalos de confiança, proporção de remissão). Os autores do estudo foram contatados se os dados apresentados no artigo fossem insuficientes para calcular os tamanhos do efeito. A inclusão dos estudos, a avaliação do risco e a extração dos dados foram realizadas por dois investigadores treinados de forma independente e verificadas

por um terceiro investigador, com um acordo inicial de 90,89%, resolvido para 100% de acordo após discussão.

Análise de dados

A Meta-Análise Abrangente (versão 3.3070; CMA) foi utilizada para calcular os tamanhos de efeito combinados entre os grupos de teleterapia e terapia presencial. Um tamanho de efeito positivo indica que a teleterapia apresentou maior eficácia do que a terapia presencial, enquanto um tamanho de efeito negativo indica que a teleterapia apresentou menor eficácia. Os tamanhos do efeito após o tratamento e no acompanhamento de 3 a 6 meses foram calculados. Também calculamos a razão de risco (RR) combinada entre os grupos de desistência, que indicou a taxa de desistência no grupo de teleterapia dividida pela taxa de desistência no grupo de terapia presencial. Uma razão de risco de 1 indicou que a taxa de desistência na teleterapia era comparável à taxa de desistência na terapia presencial. Uma razão de risco maior que um indicava que a taxa de desistência na teleterapia era maior do que a taxa de desistência na terapia presencial, enquanto uma razão de risco menor que um indicava que a taxa de desistência na teleterapia era menor do que a taxa de desistência na terapia presencial. Além disso, calculamos os tamanhos do efeito dentro do grupo para a teleterapia após o tratamento e no acompanhamento. Um modelo de efeitos aleatórios foi usado em todas as análises, pois a heterogeneidade é comumente assumida em estudos clínicos. Também calculamos o Q e o I^2 para testar a homogeneidade dos tamanhos do efeito.

Além disso, foram realizadas análises de subgrupos para as características do estudo: formato do tratamento (videoconferência vs. telefone) e

do estudo: formato do tratamento (videoconferência vs. telefone) e status da licença do profissional (licenciado vs. estagiário) para examinar se algum deles estava associado aos tamanhos do efeito combinados. Análises de sensibilidade também foram realizadas para avaliar o risco de viés, a fim de comparar o tamanho do efeito combinado de estudos com baixo risco de viés (risco baixo ou incerto em todos os itens de viés) com estudos com alto risco em pelo menos um dos oito itens de viés. Além disso, o método “um estudo removido” foi usado para examinar se a remoção sistemática de cada estudo afetava o tamanho do efeito geral. Por fim, para variáveis contínuas, análises de metarregressão foram realizadas para examinar se a idade média, o sexo e a duração do tratamento dos pacientes estavam associados aos tamanhos dos efeitos combinados no pós-tratamento e no acompanhamento, bem como na evasão.

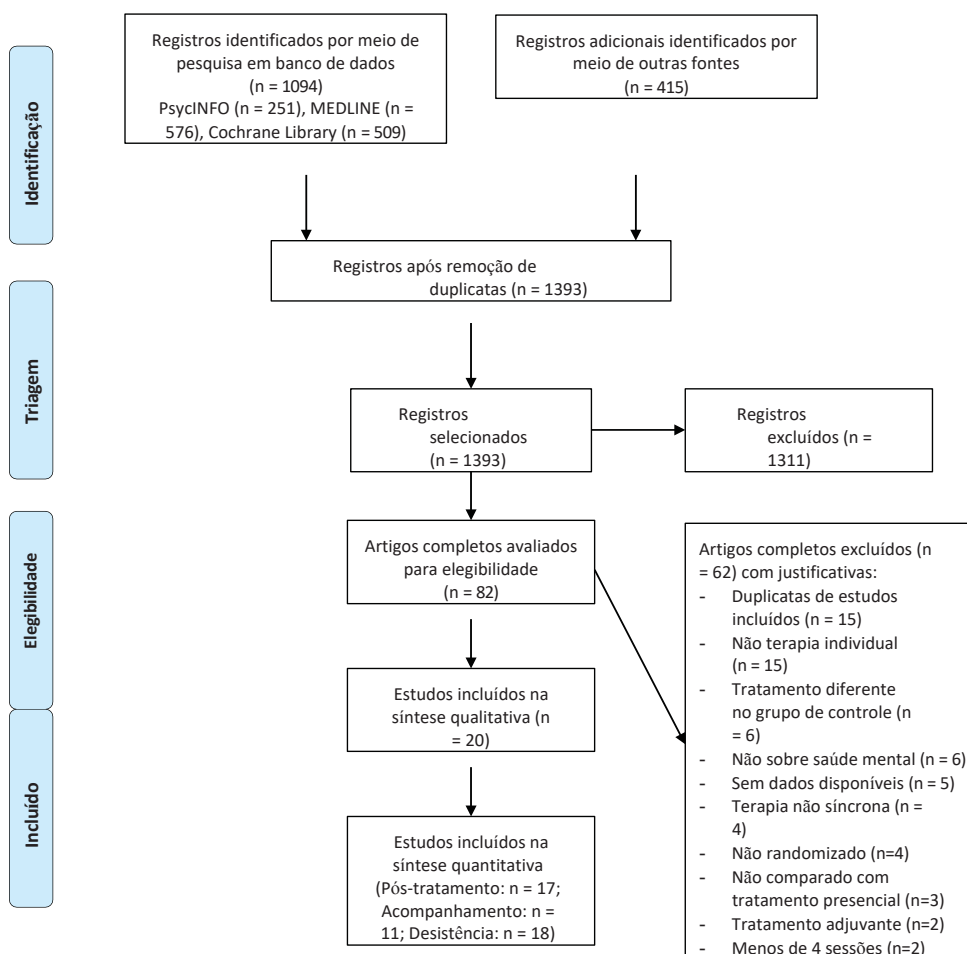
Resultados

Seleção de estudos

Um total de 1.751 estudos (1.393 após a remoção de duplicatas) foram identificados por meio dos procedimentos descritos acima. Após a triagem dos resumos, 82 artigos completos foram avaliados quanto à elegibilidade (ver [Figura 1](#)). Vinte estudos que compararam diretamente a teleterapia e a terapia presencial e satisfizeram todos os critérios de inclusão foram incluídos na metanálise. O fluxograma PRISMA descreveu o processo de inclusão e os motivos de exclusão (ver [Figura 1](#)).

Dos 20 estudos, 3 não forneceram dados suficientes para calcular os tamanhos dos efeitos e 2 não relataram taxas de atrito. Portanto, 17 estudos com 18 comparações foram incluídos na meta-análise dos tamanhos do efeito (incluindo 35 amostras únicas e 2.004 participantes), e 18 estudos com 19 comparações foram incluídos na meta-análise da taxa de desistência (incluindo 37 amostras únicas e 2.159 participantes). Além disso, 11 estudos que incluíram acompanhamento em 3

Figura 1
Seleção e exclusão de estudos



Nota. Consulte o artigo online para ver a versão colorida desta figura.

e 6 meses foram incluídos para calcular o efeito a longo prazo da teleterapia síncrona em comparação com a terapia presencial.

Características dos estudos incluídos

As características dos 20 estudos incluídos estão descritas na [Tabela 1](#). Dos 20 estudos, 6 compararam a terapia presencial com a terapia por telefone e 13 compararam a terapia presencial com a terapia por videoconferência; um estudo comparou tanto a terapia por videoconferência quanto a terapia por telefone com a terapia presencial. Os 20 estudos foram realizados nos Estados Unidos (n = 11), Canadá (n = 3), Reino Unido (n = 2), Nova Zelândia (n = 1), Espanha (n = 1), China (n = 1) e Austrália (n = 1). A maioria dos estudos testou a TCC (n = 12); outras modalidades de tratamento especificadas incluíram terapia de processamento cognitivo (CPT; n = 2), ativação comportamental (BA; n = 2), terapia de exposição (n = 1) e terapia de resolução de problemas (n = 1). Em termos de categoria diagnóstica, os estudos incluídos se concentraram principalmente em TEPT (n = 5), depressão (n = 4), transtorno de ansiedade generalizada (n = 1), transtorno alimentar (n = 1), transtorno do pânico com agorafobia (n = 1), jogo compulsivo (n = 1) e demência (n = 1). Os outros (n = 5) não se concentraram em nenhum específico.

diagnóstico de transtorno mental. A duração do tratamento variou de 5 a 20 sessões, e cada sessão durou de 30 a 90 minutos.

Avaliação do risco de viés

Entre os 20 estudos, dezoito foram considerados como tendo uma geração de sequências adequada, enquanto dois apresentavam um risco elevado de geração de sequências inadequada. Quinze estudos apresentavam taxas de desistência aceitáveis (30% para tratamentos com menos de 8 sessões; 35% para tratamentos com 8 ou mais sessões), enquanto três estudos apresentavam taxas de desistência mais elevadas; dois estudos não relataram taxas de desistência. Onze estudos realizaram análises por intenção de tratar, enquanto sete não o fizeram. Dez estudos foram pré-registrados, enquanto dez não foram. Dezesete estudos foram considerados de baixo risco para diferenças significativas na linha de base entre os grupos, enquanto três apresentaram maior risco de diferenças na linha de base entre os grupos. Quatorze estudos apresentaram menor risco de baixa adesão ao tratamento ou baixa conformidade do paciente; seis não forneceram nenhuma informação sobre a adesão ao tratamento. Em termos de relato seletivo de resultados, 17 apresentaram baixo risco. Dezesesseis estudos apresentaram baixo risco de dados incompletos de resultados. No geral, quatorze estudos apresentaram risco de alguns vieses e

Tabela 1
 Características dos estudos incluídos

Estudo	País	Formato	Modalidade	Especialização do terapeuta	Contém contato presencial	Diagnósticos/problemas	Idade (DP)	% Mulheres	Grupo de controle	<i>n</i>	Número de sessões	Acompanhamento
Acierno et al. (2016)	EUA	VC	BA	Conselheiros de nível de mestrado	Não	PTSD	45,6 (14,9)	5,60	F2F	VC: 111 F2F: 121	8	Pré e pós-tratamento, 3 m e 12 m
Acierno et al. (2017)	EUA	VC	Exposição terapia	Mestrado licenciado conselheiros	Não	TEPT	41,8 (14,5)	3,80	F2F	VC: 65 F2F: 68	10	Pré e pós-tratamento, 3 m e 6 m
Alegria et al. (2014)	EUA	TP	TCC	Psicólogos, assistentes sociais licenciados trabalhadores e conselheiro	Não	Depressão	44,9	81,71%	F2F; TAU	TP: 87 F2F: 84 TAU: 86	9	Pré e pós-tratamento, 2 m e 4 m
Arnedt et al. (2021)	EUA	VC	TCC	Psicólogo	Não	Insônia	47,2 (16,3)	70,80	F2F	VC: 31 Presencial: 31	6	Pré e pós-tratamento, 3 m
Bouchard et al. (2004)	Canadá	VC	TCC	Psicólogos, candidatos a doutorado e psicoeducadores Enfermeiros terapeutas treinados	Não	Transtorno do pânico com agorafobia	37,99	71,40%	F2F	VC: 11 F2F: 10	12	Admissão, pré e pós-tratamento, 6 m
Burgess et al. (2012)	Reino Unido	TP	TCC		Sim	Síndrome de fadiga crônica	37,4 (10,1)	78,75	F2F	TP: 45 F2F: 35	14	Pré e pós-tratamento, 3 m, 6 m e 12 m
Choi et al. (2014)	EUA	VC	PST	Assistentes sociais com nível de mestrado	Não	Depressão	64,8 (9,18)	78,48	F2F; CC	VC: 40 F2F: 45 CC: 31	6	pré-tratamento, 12 semanas, 24 semanas e 36 semanas
Cuevas et al. (2006)	Espanha	VC	TCC	Psiquiatras	Não	NS	40,21	66,43%	F2F	VC: 70 F2F: 70	8	Pré e pós-tratamento
Day e Schneider (2002)	EUA	VC e TP	TCC	Estudantes de doutorado	Não	NS	39,35 (15,88)	65,00	F2F	F2F: 27VC: 26TP: 27	5	Pré e pós-tratamento
Egede et al. (2015)	EUA	VC	BA	Mestrado licenciado conselheiros	Não	MDD	63,9 (5,1)	2,48	F2F 8 semanas,	VC: 120 F2F: 121	8	pré-tratamento, 4 semanas, 3 meses e 12 meses
Germain et al. (2009)	Canadá	VC	TCC	Psicólogos	Não	PTSD	42,33	60,40%	F2F	VC: 16 F2F: 32	20	Pré e pós-tratamento
Maieritsch et al. (2016)	EUA	VC	CPT	Psicólogos com nível de doutorado e assistentes sociais	Sim	PTSD	30,9 (6,05)	6,70%	F2F	VC: 25F2F: 26	10	Pré e pós-tratamento
Mitchell et al. (2008)	EUA	TP	TCC	Psicólogos	Não	BN ou alimentação não especificada distúrbio	29,02	98,44	F2F	TP: 62 F2F: 66	14	Pré e pós-tratamento, 3 m e 6 m
Mohr et al. (2012)	EUA	TP	TCC	Psicólogos com nível de doutorado	Não	MDD	47,7 (13,0)	77,54	F2F	TP: 163 F2F: 162	18	3 meses e 6 meses Pré e pós-tratamento,
Morland et al. (2015)	EUA	VC	CPT	NS	Não	PTSD	46,4 (11,9)	100	F2F	VC: 63 Presencial: 63	12	pré e pós-tratamento,
Poon et al. (2005)	China	VC	Cognitiva tratamento	Assistente social	Não	Deficiências cognitivas	Incerto	Não está claro	F2F	VC: 11 F2F: 11	12	Pré e pós-tratamento
Robillard et al. (2017)	Canadá	VC	TCC	Estudantes de doutorado	Não	GAD	41,15	82,05	F2F	VC: 52 F2F: 65	15	Pré e pós-tratamento, 6 m e 12 m
Stubblings et al. (2013)	Austrália	VC	TCC	Estudantes de doutorado	Sim	NS	30 (11)	57,69	F2F	VC: 14 Presencial: 12	12	Pré e pós-tratamento, 6 meses
Nota. BA = Ativação comportamental; BN = Bulimia nervosa; TCC = Terapia cognitivo-comportamental; CC = Chamada de atendimento; TPC = Terapia de processamento cognitivo; F2F = Terapia presencial; TAU = Transtorno de ansiedade generalizada; TDM = Transtorno depressivo maior; NS = Não especificado; PST = Terapia de resolução de problemas; TEPT = Transtorno de estresse pós-traumático; TAU = Tratamento habitual; TP = Terapia por telefone; VC = Terapia por videoconferência												
Watson et al. (2017)	Reino Unido	TP	TCC	NS	Não	NS	50,42	72,03	F2F	F2F: 58 TP: 60	4	Pré e pós-tratamento

Seis apresentaram baixo risco para todos os vieses (ver [Figura Suplementar 1](#) para detalhes de cada estudo).

Análises entre grupos

Efeitos pós-tratamento da teleterapia em comparação com a terapia presencial

A [Tabela 2](#) mostra os tamanhos de efeito combinados da teleterapia em comparação com a terapia presencial. O tamanho de efeito combinado entre os grupos da teleterapia síncrona versus terapia presencial após o tratamento foi $\text{hedges' } g = -0,043$ ($k = 18$; IC 95% $[-0,137, 0,051]$; $p = 0,367$), com heterogeneidade zero ($I^2 = 0$; $Q = 12,634$, $p = 0,760$). Os tamanhos de efeito combinados entre os grupos após o tratamento variaram de $-0,066$ a $-0,026$ após a remoção de cada estudo, indicando nenhuma alteração no tamanho do efeito. Especificamente, em comparação com a terapia presencial após o tratamento, os tamanhos de efeito combinados entre os grupos para a terapia por videoconferência foram $g = -0,077$ ($k = 12$; IC 95% $[-0,201, 0,046]$, $p = 0,219$) e $g = 0,004$ ($k = 6$; IC 95% $[-0,141, 0,148]$; $p = 0,960$) para a terapia administrada por telefone.

Efeitos de longo prazo da teleterapia em comparação com a terapia presencial

No acompanhamento de 3 a 6 meses, o tamanho do efeito combinado da teleterapia síncrona em comparação com a terapia presencial foi $g = -0,045$ ($k = 11$; IC 95% $[-0,151, 0,082]$; $p = 0,411$), com heterogeneidade zero ($I^2 = 0$; $Q = 6,579$; $p = 0,765$; ver [Tabela 2](#)). Especificamente, em comparação com a terapia presencial no acompanhamento, o tamanho do efeito combinado da terapia por videoconferência versus foi $g = -0,02$ ($k = 7$; IC 95% $[-0,160, 0,121]$; $p = 0,785$) e o tamanho do efeito combinado da terapia administrada por telefone foi $g = -0,055$ ($k = 4$; IC 95% $[-0,263, 0,154]$; $p = 0,607$). Os

tamanhos do efeito combinados no acompanhamento variaram de $-0,065$ a $0,005$ após a remoção de cada estudo, indicando nenhuma alteração no tamanho do efeito.

Taxa de desistência na teleterapia em comparação com a terapia presencial

A [Tabela 3](#) apresenta a razão de risco de desistência na teleterapia em comparação com a terapia presencial. A razão de risco combinada de desistência na teleterapia síncrona em comparação com a terapia presencial foi de 1,006 ($k = 19$; IC 95% $[0,850, 1,191]$; $p = 0,797$), sem heterogeneidade ($I^2 = 0$; $Q = 16,149$, $p = 0,582$). Especificamente, a razão de risco combinada de desistência na terapia por videoconferência em comparação com a terapia presencial foi de 1,249 ($k = 12$; IC 95% $[0,971, 1,607]$; $p = 0,084$). A razão de chances combinada de desistência na terapia por telefone em comparação com a terapia presencial foi de 0,852 ($k = 7$; IC 95% $[0,669, 1,085]$; $p = 0,193$). A razão de risco combinada variou de 0,970 a 1,092 após a remoção de cada estudo, indicando nenhuma alteração no tamanho do efeito.

Análises de subgrupos e metarregressões

A [Tabela 4](#) mostra as diferenças nos efeitos pós-tratamento e a longo prazo e nas taxas de desistência da teleterapia em comparação com a terapia presencial, quando os estudos foram agrupados por formato de tratamento, risco geral de viés e status de licença do terapeuta. Nenhum desses fatores moderou significativamente os tamanhos do efeito no pós-tratamento e no acompanhamento da teleterapia em comparação com a terapia presencial. É importante notar que a razão de risco de desistência na teleterapia em comparação com a terapia presencial variou de acordo com o formato do tratamento ($p = 0,032$) e o status da licença do terapeuta ($p = 0,045$). Em comparação com a terapia presencial, a terapia por videoconferência apresentou maior risco de desistência do cliente em comparação com a terapia por telefone. Em comparação com terapeutas licenciados, terapeutas em treinamento tiveram maior desistência de clientes ao administrar teleterapia.

Tabela 2

Tamanhos do efeito entre grupos comparando a telepsicologia com a terapia presencial após o tratamento e no acompanhamento

Estudo tratamento	Formato do	Pré-tratamento a pós-tratamento		Peso do estudo incluído	Pré-tratamento para acompanhamento incluído		Ponderação do estudo estudo
		g	IC 95		g	IC 95%	
Alegría et al. (2014)	TP	0,169	$[-0,130, 0,468]$	23,363	0,092	$[-0,207, 0,390]$	12,724
Burgess et al. (2012)	TP	0,210	$[-0,303, 0,723]$	7,946	0,239	$[-0,306, 0,785]$	3,819
Day e Schneider (2002)	TP	0,053	$[-0,474, 0,580]$	7,529	-0,105	$[-0,563, 0,352]$	5,417
Mitchell et al. (2008)	TP	-0,187	$[-0,622, 0,248]$	11,033	—	—	—
Mohr et al. (2012)	TP	-0,064	$[-0,294, 0,166]$	39,440	-0,236	$[-0,470, -0,001]$	20,608
Watson et al. (2017)	TP	-0,098	$[-0,540, 0,344]$	10,689	—	—	—
TP		0,004	$[-0,141, 0,148]$		-0,055	$[-0,263, 0,154]$	
Acierno et al. (2016)	VC	-0,035	$[-0,311, 0,240]$	20,027	0,006	$[-0,269, 0,282]$	14,932
Acierno et al. (2017)	VC	-0,174	$[-0,514, 0,166]$	13,151	-0,162	$[-0,502, 0,178]$	9,821
Arnedt et al. (2021)	VC	-0,094	$[-0,575, 0,387]$	6,579	-0,047	$[-0,528, 0,433]$	4,915
Bouchard et al. (2004)	VC	0,473	$[-0,370, 1,316]$	2,139	0,200	$[-0,636, 1,037]$	1,623
Choi et al. (2014)	VC	—	—	—	0,052	$[-0,332, 0,435]$	7,701
Cuevas et al. (2006)	VC	-0,067	$[-0,409, 0,275]$	12,993	—	—	—
Egede et al. (2015)	VC	-0,242	$[-0,576, 0,092]$	13,612	-0,126	$[-0,481, 0,228]$	9,036
Day e Schneider (2002)	VC	0,030	$[-0,501, 0,561]$	5,387	—	—	—
Germain et al. (2009)	VC	-0,706	$[-1,350, -0,063]$	3,672	—	—	—
Maieritsch et al. (2016)	VC	-0,090	$[-0,633, 0,454]$	5,148	—	—	—
Morland et al. (2015)	VC	0,095	$[-0,253, 0,442]$	12,606	0,109	$[-0,238, 0,457]$	9,405
Poon et al. (2005)	VC	-0,041	$[-0,846, 0,764]$	2,346	—	—	—
Stubbings et al. (2013)	VC	0,348	$[-0,458, 1,154]$	2,340	—	—	—
VC		-0,077	$[-0,201, 0,046]$		-0,020	$[-0,160, 0,121]$	
Geral		-0,043	$[-0,137, 0,051]$		-0,045	$[-0,151, 0,062]$	

Nota. TP = Terapia por telefone; VC = Terapia por videoconferência

Tabela 3

Relação de risco entre grupos comparando a taxa de desistência da telepsicologia com a terapia presencial

Estudo tratamento	Formato do	Taxas de desistência da telepsicologia versus terapia presencial terapia incluídos		Peso dos estudos estudo	Taxas de desistência da telepsicologia		Ponderação do estudo incluído
		RR	IC 95%		AR	IC 95%	
Alegría et al. (2014)	TP	0,841	[0,502, 1,409]	19,207	0,310	[0,193, 0,427]	15,995
Burgess et al. (2012)	TP	1,667	[0,680, 4,088]	6,929	0,333	[0,165, 0,502]	12,082
Day e Schneider (2002)	TP	2,266	[0,440, 11,678]	2,141	0,156	[0,019, 0,293]	14,398
Mitchell et al. (2008)	TP	0,828	[0,468, 1,464]	16,085	0,339	[0,194, 0,484]	13,790
Mohr et al. (2012)	TP	0,638	[0,414, 0,981]	26,150	0,209	[0,138, 0,279]	19,819
Tse et al. (2013)	TP	1,071	[0,640, 1,793]	19,267	0,652	[0,419, 0,886]	8,442
Watson et al. (2017)	TP	0,642	[0,309, 1,334]	10,220	0,218	[0,095, 0,342]	15,474
TP		0,852	[0,669, 1,085]		0,289	[0,204, 0,375]	
Acierno et al. (2016)	VC	1,452	[0,705, 2,992]	12,156	0,057	[0,001, 0,113]	12,231
Acierno et al. (2017)	VC	1,770	[0,892, 3,514]	13,505	0,229	[0,117, 0,341]	8,720
Arnedt et al. (2021)	VC	1,939	[0,176, 21,388]	1,102	0,246	[0,121, 0,370]	8,002
Choi et al. (2014)	VC	0,875	[0,326, 2,349]	6,508	0,333	[0,165, 0,502]	5,871
Cuevas et al. (2006)	VC	0,667	[0,188, 2,362]	3,967	0,333	[0,102, 0,564]	3,884
Day e Schneider (2002)	VC	1,933	[0,354, 10,555]	2,204	0,338	[0,197, 0,480]	7,104
Egede et al. (2015)	VC	1,186	[0,621, 2,265]	15,188	0,061	[—0,023, 0,145]	10,474
Germain et al. (2009)	VC	1,222	[0,500, 2,990]	7,933	0,125	[0,032, 0,218]	9,922
Maieritsch et al. (2016)	VC	0,882	[0,441, 1,767]	13,171	0,133	[0,003, 0,264]	7,662
Morland et al. (2015)	VC	1,192	[0,567, 2,504]	11,510	0,157	[0,086, 0,228]	11,334
Robillard, et al. (2017)	VC	1,621	[0,752, 3,492]	10,774	0,167	[0,094, 0,240]	11,179
Stubbings et al. (2013)	VC	1,286	[0,215, 7,695]	1,983	0,214	[—0,028, 0,457]	3,617
VC		1,249	[0,971, 1,607]		0,176	[0,123, 0,230]	
Geral		1,006	[0,850, 1,191]		0,219	[0,169, 0,269]	

Nota AR = taxa de desistência; RR = razão de risco; TP = terapia por telefone; VC = terapia por videoconferência

A Tabela 5 apresenta os resultados das metarregressões dos efeitos da teleterapia e das taxas de desistência na teleterapia em comparação com a terapia presencial. A idade e o sexo dos pacientes, bem como a duração do tratamento, não moderaram os efeitos pós-tratamento e acompanhamento ou as taxas de desistência na teleterapia em comparação com a terapia presencial.

Análises dentro do grupo

A Tabela 6 mostra os tamanhos do efeito agrupados dentro do grupo da teleterapia dos estudos incluídos na meta-análise. Os tamanhos do efeito agrupados dentro do grupo da teleterapia foram grandes ($k = 16$; $g = 1,026$; IC 95% [0,795, 1,256]; $p < 0,001$) desde o pré-tratamento até ao pós-tratamento, com um elevado nível de heterogeneidade ($I^2 = 82,002$; $Q = 83,343$, $p < 0,001$). Mais especificamente, os tamanhos do efeito agrupados dentro do grupo desde o pré-tratamento até ao pós-tratamento foram $g = 0,833$ ($k = 6$; IC 95% [0,537, 1,130]; $p < 0,001$) para a terapia por telefone e $g = 1,196$ ($k = 10$; IC 95% [0,830, 1,561]; $p < 0,001$) para a terapia por videoconferência.

Os tamanhos do efeito agrupados dentro do grupo da teleterapia síncrona foram mantidos ($k = 9$; $g = 1,021$; IC 95% [0,773, 1,269]; $p < 0,001$) desde o pós-tratamento até ao acompanhamento, com um elevado nível de heterogeneidade ($I^2 = 80,108$; $Q = 40,217$, $p < 0,001$). Mais especificamente, os tamanhos do efeito agrupados dentro do grupo desde o pós-tratamento até ao acompanhamento foram $g = 0,946$ ($k = 4$; IC 95% [0,689, 1,203]; $p < 0,001$) para a teleterapia Terapia por telefone e $g = 1,118$ ($k = 5$; IC 95% [0,658, 1,579]; $p < 0,001$) para a terapia por videoconferência.

As taxas de desistência combinadas na teleterapia foram de 0,219 ($k = 19$; IC 95% [0,169, 0,269]; ver Tabela 3), com um alto nível de heterogeneidade ($I^2 = 74,066$; $Q = 69,407$, $p < 0,001$). As taxas de desistência variaram de 0,057 a 0,652.

Discussão

De acordo com nosso conhecimento, o presente estudo foi a primeira meta-análise a comparar a teleterapia com a terapia presencial em termos de efeitos pós-tratamento, efeitos a longo prazo e taxas de desistência. No geral, a teleterapia síncrona demonstrou efeitos comparáveis aos da terapia presencial no pós-tratamento ($g = -0,043$) e no acompanhamento ($g = -0,045$). Análises dentro do grupo descobriram que a teleterapia produziu grandes tamanhos de efeito combinados após o tratamento ($g = 1,026$) e que esses efeitos foram mantidos no acompanhamento de 3 a 6 meses ($g = 1,021$). Dado o potencial de custos associados mais baixos e acesso mais fácil à teleterapia (Crow et al., 2009; Egede et al., 2018; Kafali et al., 2014), a prestação remota de psicoterapia parece ser particularmente promissora e igualmente eficaz quanto a terapia presencial.

Essas descobertas são consistentes com comparações anteriores entre a teleterapia e a terapia presencial. Em uma meta-análise da teleterapia síncrona para depressão (Osenbach et al., 2013), o tamanho do efeito combinado de seis estudos que compararam a terapia remota com a terapia presencial foi de -0,11 (ou seja, uma diferença não significativa). Além disso, Wootton (2016) sintetizou quatro estudos que compararam a TCC remota com a TCC presencial e descobriu que as diferenças no tamanho do efeito não eram clinicamente significativas, mas marginalmente estatisticamente significativas após o tratamento ($g = -0,21$; IC 95% [—0,43, 0,02]) e folbaixo ($g = -0,28$; IC 95% [—0,58, 0,00]). Isso pode ser porque dois dos quatro estudos utilizaram tratamento de teleterapia assíncrona, que produz efeitos menores (Wootton, 2016). Em comparação com resultados anteriores, este estudo identificou um número maior de estudos e encontrou tamanhos de efeito menores entre os grupos para os dois formatos de tratamento. Notavelmente, as diferenças nos tamanhos de efeito neste estudo e em estudos anteriores, embora não estejam em níveis tradicionalmente significativos, não

Tabela 4

Análise de subgrupos sobre os efeitos pós-tratamento e acompanhamento e desistência da telepsicologia em comparação com a terapia presencial

Moderador (k)	g de Hedges	RR	IC 95%	Valor <i>Q</i>	Valor <i>p</i>
Efeito após o tratamento					
Formato				0,700	0,403
Videoconferência (12)	—0,077		[—0,201, 0,046]		
Telefone (6)	0,004		[—0,141, 0,148]		
Licença de terapeuta				1,080	0,299
Licenciado (11)	—0,081		[—0,195, 0,033]		
Estagiário (5)	0,044		[—0,163, 0,252]		
Risco geral de viés				0,789	0,374
Alto (13)	—0,005		[—0,131, 0,120]		
Baixo (5)	—0,091		[—0,232, 0,050]		
Efeito no acompanhamento					
Formato				0,075	0,784
Videoconferência (7)	—0,020		[—0,160, 0,121]		
Telefone (4)	—0,055		[—0,263, 0,151]		
Licença de terapeuta				0,508	0,476
Licenciado (8)	—0,080		[—0,204, 0,044]		
Estagiário (2)	0,025		[—0,236, 0,287]		
Risco geral de viés				2,251	0,134
Alto (5)	0,063		[—0,113, 0,239]		
Baixo (6)	—0,107		[—0,240, 0,027]		
Formato de atrito				4,611	0,032
Videoconferência (12)		1,249	[0,971, 1,607]		
Telefone (7)		0,852	[0,669, 1,085]		
Licença de terapeuta				4,035	0,045*
Licenciado (12)		0,948	[0,782, 1,150]		
Estagiário (5)		1,587	[0,998, 2,525]		
Risco geral de viés				0,076	0,783
Alto (13)		1,063	[0,857, 1,318]		
Baixo (6)		0,999	[0,682, 1,464]		

Nota: RR = risco de viés; TP = terapia por telefone; VC = terapia por videoconferência.

* *p* < 0,05.

ligeiramente favorável à terapia presencial, sugerindo que são necessários mais estudos para examinar os efeitos da teleterapia.

O formato do tratamento e as variáveis demográficas dos pacientes não moderaram significativamente os tamanhos dos efeitos combinados entre os grupos na teleterapia versus terapia presencial. Em particular, a terapia por telefone mostrou

eficácia equivalente à terapia por videoconferência, sugerindo que os principais ingredientes terapêuticos podem ser transmitidos pelos terapeutas e percebidos pelos clientes, apesar da falta de pistas visuais. Deve-se observar, no entanto, que os estudos incluídos se concentraram apenas em tratamentos cognitivos e/ou comportamentais e em tipos limitados de transtornos psiquiátricos. Muitos potenciais

Tabela 5

Metarregressão sobre os efeitos após o tratamento e acompanhamento e desistência da telepsicologia versus terapia presencial

Moderador	Coefficiente	IC 95	Valor Z	Valor <i>p</i>
Efeitos após o tratamento				
Interceptação	0,114	[—0,568, 0,795]	0,33	0,744
Idade	—0,003	[—0,016, 0,010]	—0,46	0,643
Gênero: % de mulheres	0,212	[—0,090, 0,509]	1,40	0,162
Duração do tratamento	—0,013	[—0,036, 0,009]	—1,16	0,247
Efeito no acompanhamento				
Interceptação	0,361	[—0,443, 1,165]	0,88	0,378
Idade	—0,004	[—0,017, 0,009]	—0,63	0,526
Gênero: % de mulheres	0,187	[—0,122, 0,497]	1,19	0,236
Duração do tratamento	—0,028	[—0,057, 0,001]	—1,87	0,062
Atrito				
Interceptação	0,732	[—0,407, 1,872]	1,26	0,208
Idade	—0,008	[—0,030, 0,012]	—0,76	0,448
Gênero: % de mulheres	—0,399	[—0,934, 0,136]	—1,46	0,144
Duração do tratamento	—0,012	[—0,052, 0,027]	—0,60	0,546

Nota: TP = Terapia por telefone; VC = Terapia por videoconferência.

* *p* < 0,05.

Tabela 6

Tamanhos do efeito com grupo da telepsicologia após o tratamento e acompanhamento

Estudo tratamento	Formato do	Pré-tratamento ao pós- tratamento		Ponderação do estudo incluído	Pré-tratamento ao acompanhame nto		Ponderação do estudo incluído
		g	IC 95%		g	IC 95%	
Alegria et al. (2014)	TP	0,731	[0,489, 0,973]	18,878	0,852	[0,599, 1,105]	29,011
Burgess et al. (2012)	TP	0,879	[0,455, 1,302]	14,985	0,885	[0,429, 1,342]	17,765
Day e Schneider (2002)	TP	0,548	[0,153, 0,942]	15,619	—	—	—
Mitchell et al. (2008)	TP	0,715	[0,376, 1,054]	16,837	0,713	[0,357, 1,070]	22,725
Mohr et al. (2012)	TP	1,378	[1,156, 1,601]	19,244	1,244	[1,014, 1,474]	30,499
Watson et al. (2017)	TP	0,641	[0,192, 1,090]	14,436	—	—	—
TP		0,833	[0,537, 1,130]		0,946	[0,689, 1,203]	
Acerno et al. (2017)	VC	1,225	[0,970, 1,480]	12,243	1,304	[1,043, 1,565]	22,542
Arndt et al. (2021)	VC	1,789	[1,244, 2,334]	10,099	1,861	[1,302, 2,420]	17,894
Bouchard et al. (2004)	VC	1,231	[0,473, 1,989]	8,350	1,036	[0,323, 1,749]	15,362
Choi et al. (2014)	VC	—	—	—	1,062	[0,732, 1,392]	21,603
Cuevas et al. (2006)	VC	1,783	[1,354, 2,212]	11,040			
Day e Schneider (2002)	VC	0,619	[0,209, 1,029]	11,190	—	—	—
Germain et al. (2009)	VC	3,094	[1,921, 4,268]	5,568	—	—	—
Maieritsch et al. (2016)	VC	0,967	[0,498, 1,437]	10,718			
Morland et al. (2015)	VC	0,454	[0,197, 0,710]	12,236	0,454	[0,198, 0,711]	22,598
Poon et al. (2005)	VC	0,893	[0,223, 1,563]	9,063			
Stubbings et al. (2013)	VC	0,879	[0,261, 1,497]	9,492	—	—	—
VC		1,196	[0,830, 1,561]		1,118	[0,658, 1,579]	
Geral		1,026	[0,795, 1,256]		1,021	[0,773, 1,269]	

Nota. TP = Terapia por telefone; VC = Terapia por videoconferência.

Os moderadores (por exemplo, contexto clínico) para determinar quais locais e fatores são mais propícios à teleterapia permaneceram desconhecidos.

É prematuro concluir que a teleterapia é tão eficaz quanto a terapia presencial em todas as condições, sintomas e populações de pacientes. Pacientes com problemas psiquiátricos graves podem exigir mais envolvimento do terapeuta e, portanto, podem apresentar melhores resultados na terapia presencial (Koblauch et al., 2018). Por exemplo, Mohr et al. (2011) não encontraram benefícios significativos para uma TCC ministrada por telefone em 16 sessões em relação ao TAU e atribuíram os resultados nulos à natureza única da amostra (veteranos), que podem ter sido mais refratários ao tratamento em geral do que outras populações. Em outro RCT com características específicas de tratamento (pacientes com bulimia nervosa), Mitchell et al. (2008) descobriram que a TCC presencial produziu reduções significativamente maiores em certos sintomas em comparação com a TCC por telefone. Pesquisadores e profissionais podem não fornecer teleterapia a pacientes que, em sua opinião, provavelmente não se beneficiarão ou não são adequados para a teleterapia, o que pode ter resultado em viés de seleção. Portanto, mais pesquisas são necessárias para examinar os potenciais moderadores da eficácia da teleterapia.

A teleterapia não diferiu significativamente da terapia presencial em termos de taxas de desistência. No entanto, as taxas de desistência variaram em função do formato do tratamento e da experiência do terapeuta. A terapia por videoconferência apresentou taxas de desistência mais elevadas do que a terapia presencial, enquanto a terapia por telefone apresentou taxas de desistência mais baixas do que a terapia presencial. Talvez a terapia por telefone seja mais fácil de acessar e operar tecnicamente do que a terapia por videoconferência. A terapia por videoconferência apresenta mais disparidades entre os pacientes no uso da tecnologia do que a terapia por telefone, incluindo disparidades na qualidade dos equipamentos pessoais, acesso à internet e atitudes dos clientes em relação à tecnologia (por exemplo, Schuster et al., 2020). Por exemplo, os clientes podem participar de sessões por telefone em locais sem redes e equipamentos necessários para videochamadas.

Além disso, enquanto os terapeutas licenciados apresentaram taxas de desistência comparáveis na teleterapia e na terapia presencial, os terapeutas estagiários apresentaram taxas de desistência mais elevadas durante a teleterapia do que durante a terapia presencial.

terapia. Um estudo recente revelou que, em comparação com terapeutas mais velhos, as habilidades dos terapeutas jovens em construir alianças e reparar alianças rompidas foram mais afetadas pela telecomunicação (Lin et al., no prelo). Enquanto terapeutas experientes podem ser competentes na construção de uma aliança forte remotamente e aproveitar as vantagens oferecidas pela teleterapia, terapeutas em formação podem achar difícil construir uma aliança forte e se envolver suficientemente na teleterapia, o que foi ainda mais associado ao abandono do cliente (Sharf et al., 2010). Pode ser necessário fornecer treinamento relevante e mais realista para terapeutas menos experientes, a fim de aprimorar suas habilidades em teleterapia.

Vale ressaltar que, apesar dos sucessos documentados da teleterapia, muitos profissionais da área psicológica continuam a duvidar de sua eficácia e relatam preferência e maior competência na terapia presencial (Perle et al., 2014; Perry et al., 2020). Pode haver várias explicações para esse fenômeno. Primeiro, a preferência dos terapeutas pela terapia presencial pode se basear mais no que é tradicional e conveniente e menos em evidências empíricas. Por exemplo, os terapeutas podem não estar dispostos a usar a teleterapia devido a possíveis inconvenientes técnicos e políticas específicas da teleterapia (por exemplo, obter consentimento para telepsicologia). Segundo, a teleterapia pode ser inferior à terapia presencial em alguns aspectos da terapia (por exemplo, expressão de emoções), mesmo que essas questões possam não ser necessárias para resultados positivos para o cliente. Além disso, enquanto os terapeutas em RCTs normalmente recebem treinamento e seguem manuais de intervenção, esses mesmos apoios podem não estar disponíveis na prática comunitária.

Limitações e orientações futuras

Várias limitações desta meta-análise devem ser observadas. Em primeiro lugar, vários moderadores potenciais da teleterapia não foram examinados. Por exemplo, não foi possível examinar a raça/etnia como moderador, pois alguns estudos não relataram a raça/etnia e alguns estudos foram realizados em outros países com distribuição racial/étnica diferente. Da mesma forma, os estudos incluídos abrangeram apenas

tipos limitados de transtornos psiquiátricos e contextos clínicos. A comparabilidade da teleterapia com a terapia presencial para outros transtornos e em outros contextos deve ser mais investigada. Como a maioria dos estudos incluídos nesta meta-análise utilizou abordagens cognitivas e comportamentais, são necessárias mais pesquisas para examinar a eficácia das modalidades de terapia não cognitiva e não comportamental ministradas remotamente. Em segundo lugar, este estudo se concentrou na terapia individual para adultos. Pesquisas futuras devem examinar se a teleterapia pode alcançar efeitos equivalentes para crianças e adolescentes e quando ministrada em formato de grupo.

Em terceiro lugar, embora esta meta-análise tenha sintetizado a eficácia da teleterapia em um acompanhamento de 3 a 6 meses, não foi possível examinar os efeitos a longo prazo, pois apenas um número limitado de estudos incluídos apresentava medições de acompanhamento a longo prazo. Além disso, este estudo sintetizou os resultados de RCTs. Dados os potenciais desafios na prestação de tratamento remoto na prática comunitária, futuras meta-análises também poderão incluir resultados de contextos naturalísticos. Por fim, a presente meta-análise incluiu apenas um número limitado de estudos realizados antes da pandemia. Os resultados das análises de subgrupos e metarregressões devem ser interpretados com cautela. Futuras meta-análises podem atualizar os resultados atuais, incluindo mais estudos de teleterapia na era pós-pandêmica.

Implicações e conclusão

Este estudo constatou que a teleterapia era comparável à terapia presencial no que diz respeito à melhoria dos sintomas e pode alcançar efeitos igualmente significativos após o tratamento e no acompanhamento. A terapia por telefone pode ser um tratamento alternativo confiável para pacientes com acesso limitado à internet ou aos equipamentos necessários para comunicação por videoconferência. Além disso, o estudo examinou moderadores dos efeitos e taxas de desistência da teleterapia em comparação com a terapia presencial para determinar quais situações podem ser mais ideais para a teleterapia. Os terapeutas em formação podem estar em maior risco de abandono dos clientes na teleterapia em comparação com a terapia presencial. Essas descobertas podem informar a abordagem ideal para a prestação de serviços de teleterapia. Por exemplo, considerando sua eficácia comparável, a terapia por telefone pode ser um bom tratamento alternativo à terapia por videoconferência quando a tecnologia necessária não está disponível. Além disso, os clientes que recebem terapia por telefone podem ser mais propensos a permanecer no tratamento para experimentar o “efeito da dose” completa. Nossa meta-análise ressalta a comparabilidade entre a teleterapia e a terapia presencial. A teleterapia tem o potencial de melhorar a saúde psicológica e alcançar pacientes que, de outra forma, não seriam alcançados. Por fim, esta meta-análise pode fornecer um roteiro para pesquisas futuras sobre teleterapia para vários transtornos e em diferentes contextos.

Referências

- Acierno, R., Gros, D. F., Ruggiero, K. J., Hernandez-Tejada, B. M. A., Knapp, R. G., Lejuez, C. W., Muzzy, W., Frueh, C. B., Egede, L. E., & Tuerk, P. W. (2016). Ativação comportamental e exposição terapêutica para transtorno de estresse pós-traumático: um estudo de não inferioridade do tratamento presencial versus telessaúde domiciliar. *Depressão e Ansiedade*, 33(5), 415–423. <https://doi.org/10.1002/da.22476>
- Acierno, R., Knapp, R., Tuerk, P., Gilmore, A. K., Lejuez, C., Ruggiero, K., Muzzy, W., Egede, L., Hernandez-Tejada, M. A., & Foa, E. B. (2017). Um ensaio de não inferioridade da exposição prolongada para o transtorno de estresse pós-traumático: presencial versus telessaúde domiciliar. *Behaviour Research and Therapy*, 89, 57–65. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2016.11.009>
- Alegria, M., Ludman, E., Kafali, E. N., Lapatin, S., Vila, D., Shrout, P. E., Keefe, K., Cook, B., Ault, A., Li, X., Bauer, A. M., Epelbaum, C., Alcantara, C., Pineda, T. I. G., Tejera, G. G., Suau, G., Leon, K., Lessios, A. S., Ramirez, R. R., & Canino, G. (2014). Eficácia da intervenção de envolvimento e aconselhamento para latinos (ECLA) em latinos de baixa renda. *Medical Care*, 52(11), 989–997. <https://doi.org/10.1097/MLR.0000000000000232>
- Arndt, J. T., Conroy, D. A., Mooney, A., Furgal, A., Sen, A., & Eisenberg, D. (2021). Telemedicina versus terapia cognitivo-comportamental presencial para insônia: um ensaio clínico randomizado controlado de não inferioridade. *Sleep*, 44(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/sleep/zsaa136>
- Bee, P. E., Bower, P., Lovell, K., Gilbody, S., Richards, D., Gask, L., & Roach, P. (2008). Psicoterapia mediada por tecnologias de comunicação remota: uma revisão meta-analítica. *BMC Psychiatry*, 8(60). <https://doi.org/10.1186/1471-244X-8-60>
- Bolton, A. J., & Dorstyn, D. S. (2015). Telepsicologia para o transtorno de estresse pós-traumático: uma revisão sistemática. *Revista de Telemedicina e Telecuidado*, 21(5), 1–14. <https://doi.org/10.1177/1357633X15571996>
- Bouchard, S., Paquin, B., Payeur, R., Allard, M., Rivard, V., Fournier, T., Renaud, P., & Lapierre, J. (2004). Aplicação da terapia cognitivo-comportamental para o transtorno do pânico com agorafobia em videoconferência. *Telemedicine Journal and e-Health*, 10(1), 13–25. <https://doi.org/10.1089/153056204773644535>
- Brenes, G. A., Ingram, C. W., & Danhauer, S. C. (2011). Benefícios e desafios da realização de psicoterapia por telefone. *Psicologia Profissional, Pesquisa e Prática*, 42(6), 543–549. <https://doi.org/10.1037/a0026135>
- Burgess, M., Andiappan, M., & Chalder, T. (2012). Terapia cognitivo-comportamental para a síndrome da fadiga crônica em adultos: tratamento presencial versus tratamento por telefone: um ensaio clínico randomizado controlado. *Psicoterapia Comportamental e Cognitiva*, 40(2), 175–191. <https://doi.org/10.1017/S1352465811000543>
- Chiauzzi, E., Clayton, A., & Huh-Yoo, J. (2020). Saúde mental à distância baseada em videoconferência: questões importantes para a era da COVID-19 a partir de perspectivas clínicas e centradas no paciente. *JMIR Mental Health*, 7(12), e24021. <https://doi.org/10.2196/24021>
- Choi, N. G., Marti, C. N., Bruce, M. L., Hegel, M. T., Wilson, N. L., & Kunik, M. E. (2014). Resultados de depressão e incapacidade seis meses após a intervenção da terapia de resolução de problemas por telessaúde em casa para idosos de baixa renda, com depressão e confinados em casa. *Depressão e Ansiedade*, 31(8), 653–661. <https://doi.org/10.1002/da.22242>
- Crow, S. J., Mitchell, J. E., Crosby, R. D., Swanson, S. A., Wonderlich, S., & Lancaster, K. (2009). A relação custo-benefício da terapia cognitivo-comportamental para bulimia nervosa ministrada por telemedicina em comparação com a terapia presencial. *Behaviour Research and Therapy*, 47(6), 451–453. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2009.02.006>
- Cuevas, C. D. L., Arredondo, M. T., Cabrera, M. F., Sulzenbacher, H., & Meise, U. (2006). Ensaio clínico randomizado de telepsiquiatria por videoconferência versus tratamento psiquiátrico convencional presencial. *Revista de Telemedicina e Saúde Eletrônica*, 12(3), 341–350.
- Day, S. X., & Schneider, P. L. (2002). Psicoterapia utilizando tecnologia à distância: uma comparação entre tratamento presencial, por vídeo e por áudio. *Jornal de Psicologia de Aconselhamento*, 49(4), 499–503. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.49.4.499>
- Egede, L. E., Acierno, R., Knapp, R. G., Lejuez, C., Hernandez-Tejada, M., Payne, E. H., & Frueh, B. C. (2015). Psicoterapia para depressão em veteranos idosos via telemedicina: um ensaio clínico randomizado, aberto e sem inferioridade. *The Lancet. Psychiatry*, 2(8), 693–701. [https://doi.org/10.1016/S2058-1001\(15\)00001-0](https://doi.org/10.1016/S2058-1001(15)00001-0)
- Egede, L. E., Dismuke, C. E., Walker, R. J., Acierno, R., & Frueh, B. C. (2018). Custo-efetividade da ativação comportamental para depressão em veteranos idosos: atendimento presencial versus telessaúde. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 79(5), 17m11888. <https://doi.org/10.4088/JCP.17m11888>
- Germain, V., Marchand, A., Bouchard, S., Drouin, M. S., & Guay, S. (2009). Eficácia da terapia cognitivo-comportamental administrada por videoconferência para o transtorno de estresse pós-traumático. *Terapia Cognitivo-Comportamental*, 38(1), 42–53. <https://doi.org/10.1080/16506070802473494>

- Glueckauf, R. L., Maheu, M. M., Drude, K. P., Wells, B. A., Wang, Y., Gustafson, D. J., & Nelson, E. L. (2018). Pesquisa sobre as práticas de saúde comportamental à distância dos psicólogos: uso de tecnologia, questões éticas e necessidades de treinamento. *Psicologia Profissional, Pesquisa e Prática*, 49(3), 205–219. <https://doi.org/10.1037/pro0000188>
- Higgins, J., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M., & Welch, V. (Eds.). (2020). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 6.1*. Cochrane. www.training.cochrane.org/handbook
- Hilty, D. M., Ferrer, D. C., Parish, M. B., Johnston, B., Callahan, E. J., & Yellowlees, P. M. (2013). A eficácia da telessaúde mental: uma revisão de 2013. *Telemedicine Journal and e-Health*, 19(6), 444–454. <https://doi.org/10.1089/tmj.2013.0075>
- Kafali, N., Cook, B., Canino, G., & Alegria, M. (2014). Custo-efetividade de um ensaio randomizado para tratar a depressão entre latinos. *The Journal of Mental Health Policy and Economics*, 17(2), 41–50.
- Koblauch, H., Reinhardt, S. M., Lissau, W., & Jensen, P. L. (2018). O efeito das modalidades telepsiquiátricas na redução das readmissões em contextos psiquiátricos: uma revisão sistemática. *Revista de Telemedicina e Tel ecare*, 24(1), 31–36. <https://doi.org/10.1177/1357633X16670285>
- Lin, T., Stone, S. J., Anderson, T., Lin, T., & Anderson, T. (2021). Tratamento à distância: desafios e preocupações dos profissionais de saúde mental durante a pandemia da COVID-19. *Medicina Comportamental*. Publicação online antecipada. <https://doi.org/10.1080/08964289.2021.1908217>
- Lin, T., Stone, S. J., Heckman, T., & Anderson, T. (no prelo). Zoom-in para se desconectar: terapeutas relatam menos habilidade terapêutica na telepsicologia em comparação com a terapia presencial durante a pandemia da COVID-19. *Psicoterapia*.
- Maieritsch, K. P., Smith, T. L., Hessinger, J. D., Ahearn, E. P., Eickhoff, J. C., & Zhao, Q. (2016). Ensaio clínico randomizado controlado comparando videoconferência e terapia presencial de processamento cognitivo para TEPT. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 22(4), 238–243. <https://doi.org/10.1177/1357633X15596109>
- Markowitz, J. C., Milrod, B., Heckman, T. G., Bergman, M., Amsalem, D., Zalman, H., Ballas, T., & Neria, Y. (2021). Psicoterapia à distância. *The American Journal of Psychiatry*, 178(3), 240–246. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20050557>
- Marques, L., LeBlanc, N. J., Weingarden, H. M., Timpano, K. R., Jenike, M., & Wilhelm, S. (2010). Barreiras ao tratamento e à utilização de serviços em uma amostra da internet de indivíduos com sintomas obsessivo-compulsivos. *Depressão e Ansiedade*, 27(5), 470–475. <https://doi.org/10.1002/da.20694>
- Mitchell, J. E., Crosby, R. D., Wonderlich, S. A., Crow, S., Lancaster, K., Simonich, H., Swan-Kremeier, L., Lysne, C., & Myers, T. C. (2008). Um ensaio aleatório comparando a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para bulimia nervosa ministrada por telemedicina versus presencial. *Behaviour Research and Therapy*, 46(5), 581–592. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2008.02.004>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Group, T. P., & o Grupo PRISMA. (2009). Itens preferenciais para relatórios de revisões sistemáticas e meta-análises: a declaração PRISMA. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Mohr, D. C., Carmody, T., Erickson, L., Jin, L., & Leader, J. (2011). Terapia cognitivo-comportamental administrada por telefone para veteranos atendidos por clínicas ambulatoriais comunitárias. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 79(2), 261–265. <https://doi.org/10.1037/a0022395>
- Mohr, D. C., Hart, S. L., Howard, I., Julian, L., Vella, L., Catledge, C., & Feldman, M. D. (2006). Barreiras à psicoterapia entre pacientes de cuidados primários deprimidos e não deprimidos. *Anais de Medicina Comportamental*, 32(3), 254–258. https://doi.org/10.1207/s15324796abm3203_12
- Mohr, D. C., Ho, J., Duffecy, J., Reifler, D., Sokol, L., Burns, M. N., Jin, L., Siddique, J., Jin, L., & Siddique, J. (2012). Efeito da terapia cognitivo-comportamental administrada por telefone versus presencial na adesão à terapia e nos resultados da depressão entre pacientes de cuidados primários: um ensaio randomizado. *Journal of the American Medical Association*, 307(21), 2278–2285. <https://doi.org/10.1001/jama.2012.5588>
- Mohr, D. C., Vella, L., Hart, S., Heckman, T., & Simon, G. (2008). O efeito da psicoterapia administrada por telefone nos sintomas de depressão e desgaste: uma meta-análise. *Psicologia Clínica: Ciência e Prática*, 15(3), 243–253. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.2008.00134.x>
- Morland, L. A., Mackintosh, M. A., Rosen, C. S., Willis, E., Resick, P., Chard, K., Frueh, B. C., Resick, P., Ph, D., Chard, K., Ph, D., Frueh, B. C., & Ph, D. (2015). Telemedicina versus terapia presencial de processamento cognitivo para mulheres com transtorno de estresse pós-traumático: um ensaio clínico randomizado de não inferioridade. *Depressão e Ansiedade*, 32(11), 811–820. <https://doi.org/10.1002/da.22397>
- Osenbach, J. E., O'Brien, K. M., Mishkind, M., & Smolenski, D. J. (2013). Tecnologias de telessaúde síncronas na psicoterapia para depressão: uma meta-análise. *Depressão e Ansiedade*, 30(11), 1058–1067. <https://doi.org/10.1002/da.22165>
- Perry, J. G., Burt, J., & Higgins, W. J. (2014). Interesse de psicólogos e médicos em treinamento em telessaúde e encaminhamento para serviços de saúde mental: um estudo exploratório. *Jornal de Tecnologia em Serviços Humanos*, 32(3), 158–185. <https://doi.org/10.1080/15228835.2014.894488>
- Perry, K., Gold, S., & Shearer, E. M. (2020). Identificação e abordagem das barreiras percebidas pelos profissionais de saúde mental à utilização da telessaúde clínica por vídeo. *Revista de Psicologia Clínica*, 76(6), 1125–1134. <https://doi.org/10.1002/jclp.22770>
- Pierce, B. S., Perrin, P. B., & McDonald, S. D. (2019). Preditores demográficos, organizacionais e de prática clínica do uso da telepsicologia por psicólogos dos EUA. *Psicologia Profissional, Pesquisa e Prática*, 51(2), 184–193. <https://doi.org/10.1037/pro0000267>
- Pierce, B. S., Perrin, P. B., Tyler, C. M., McKee, G. B., & Watson, J. D. (2021). A revolução da telepsicologia da COVID-19: Um estudo nacional sobre as mudanças na prestação de cuidados de saúde mental nos EUA devido à pandemia. *American Psychologist*, 76(1), 14–25. <https://doi.org/10.1037/amp0000722>
- Poon, P., Hui, E., Dai, D., Kwok, T., & Woo, J. (2005). Intervenção cognitiva para idosos com problemas de memória que vivem em comunidade: telemedicina versus tratamento presencial. *Revista Internacional de Psiquiatria Geriátrica*, 20(3), 285–286.
- Robillard, G., Bouchard, S., Marcotte-Beaumier, G., Dugas, M. J., Marchand, A., Gosselin, P., Langlois, F., & Belleville, G. (26 a 28 de junho de 2017). *Eficácia da telepsicoterapia para o transtorno de ansiedade generalizada (TAG): resultados finais após 6 a 12 meses de acompanhamento* [Apresentação de artigo]. 22ª Conferência Anual de Ciberpsicologia, Ciberterapia e Redes Sociais (CYPSSY22), Wolverhampton, Inglaterra.
- Sammons, M. T., VandenBos, G. R., & Martin, J. N. (2020). Prática psicológica e a crise da COVID-19: uma pesquisa de resposta rápida. *Journal of Health Service Psychology*, 46(2), 1–7. <https://doi.org/10.1007/s42843-019-00002-0>
- Schuster, R., Topocoo, N., Keller, A., Radvogin, E., & Laireiter, A. R. (2020). Vantagens e desvantagens da terapia online e mista: replicação e extensão das conclusões sobre as avaliações dos psicoterapeutas. *Intervenções na Internet: A aplicação da tecnologia da informação na saúde mental e comportamental*, 21, 100326. <https://doi.org/10.1016/j.invent.2020.100326>
- Sharf, J., Primavera, L. H., & Diener, M. J. (2010). Abandono e aliança terapêutica: uma meta-análise da psicoterapia individual em adultos. *Psicoterapia: Teoria, Pesquisa e Prática*, 47(4), 637–645. <https://doi.org/10.1037/a0021175>
- Stubbings, D. R., Rees, C. S., Roberts, L. D., & Kane, R. T. (2013). Comparação entre terapia cognitivo-comportamental presencial e por videoconferência para transtornos de humor e ansiedade: ensaio clínico randomizado controlado. *Journal of Medical Internet Research*, 15(11), e258. <https://doi.org/10.2196/jmir.2564>
- Força-Tarefa de Telepsicologia. (2013). Diretrizes para a prática da telepsicologia. *American Psychologist*, 68(9), 791–800. <https://doi.org/10.1037/a0035001>
- Tse, S., Campbell, L., Rossen, F., Wang, C.-W., Jull, A., Yan, E., & Jackson, A. (2013). Aconselhamento presencial e por telefone para

- o problemático ao jogo: Um estudo pragmático multissítio randomizado. *Pesquisa sobre Prática de Serviço Social*, 23(1), 57–65. <https://doi.org/10.1177/1049731512466150>
- Varker, T., Brand, R. M., Ward, J., Terhaag, S., & Phelps, A. (2019). Eficácia das intervenções síncronas de telepsicologia para pessoas com ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de adaptação: uma avaliação rápida das evidências. *Serviços psicológicos*, 16(4), 621–635. <https://doi.org/10.1037/ser0000239>
- Watson, M., White, C., Lynch, A., & Mohammed, K. (2017). Terapia cognitivo-comportamental individual por telefone para pacientes com câncer: um ensaio clínico randomizado de equivalência. *Psico-Oncologia*, 26(3), 301–8. <https://doi.org/10.1002/pon.4338>
- Wood, J. (2008). Metodologia para lidar com efeitos de estudos duplicados em uma meta-análise. *Métodos de Pesquisa Organizacional*, 11(1), 79–95. <https://doi.org/10.1177/1094428106296638>
- Wootton, B. M. (2016). Terapia cognitivo-comportamental remota para sintomas obsessivo-compulsivos: uma meta-análise. *Clinical Psychology Review*, 43, 103–113. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.10.001>

Recebido em 22 de abril de
2021 Revisão recebida em 25 de setembro de
2021

Aceito em 1º de novembro de 2021 ■